Entregable Individual U2-E02.

Datos iniciales

- **Nombre:** Gustavo Ángel García Estrada
- **Equipo:** FantasticFour_CitaMed-IA
- **Proyecto:** CitaMed-IA
- **Rol en el equipo**: Calidad y Documentación

Proceso y mejora que analizaras:

Yo observaré la confirmación automatizada de citas y el envío de recordatorios para reducir el ausentismo de pacientes y las llamadas en recepción. La mejora propone que CitaMed-IA envíe notificaciones automáticas y procese reagendamientos de manera inmediata durante las 24 horas del día.

Que debe cumplirse

- **Regla y paso donde se aplica:**

Antes de registrar una cita como "Confirmada", CitaMed-IA debe validar que existan los datos obligatorios del paciente (nombre completo, teléfono de contacto y motivo general de consulta/especialidad). Se aplica en el paso 4 del flujo TO-BE, justo después de seleccionar el horario disponible.

Como sabes que esa regla existe:

- **Fuente que lo confirma**

Se establece en el apartado de Entradas/Salidas del proceso principal del documento U2-E01. Es indispensable para garantizar que la agenda del médico cuente con la información básica para la atención presencial.

Quien la comprueba y con que información

El área de Calidad comprueba mediante pruebas de usuario que el flujo no permita reservas incompletas. El personal de recepción verifica que los datos en la agenda sean legibles y suficientes para recibir al paciente.

Un ejemplo donde se cumple y que ocurre

El paciente ingresa sus datos completos a través de CitaMed-IA, el sistema confirma el horario seleccionado y le envía un comprobante digital con la fecha, hora y especialista, agendando además un recordatorio automático.

Un ejemplo donde no se cumple y que ocurre:

El sistema permite apartar una cita sin haber registrado el número telefónico del paciente. El recordatorio no se puede entregar, aumentando el riesgo de ausentismo o imposibilidad de contactar al paciente si el médico debe cancelar.

Tabla 1:

1. Que podría salir mal

¿Que podría ocurrir?	**¿Por qué?**	**¿A quién o qué actividad afectaría?**	**¿Qué harías para prevenirlo y atenderlo?**
Los pacientes adultos mayores u otros usuarios prefieren llamar por teléfono y no usan el asistente.	Falta de hábito con interfaces conversacionales o dificultad de uso de la herramienta interactiva.	A la meta del indicador de automatización (>50% de reducción de llamadas) y a la recepción.	Diseñar una interfaz sumamente amigable e instruir a las recepcionistas para promover el canal de IA al contestar llamadas telefónicas.
El paciente no recibe la notificación de recordatorio y falta a su cita.	Errores en la API del proveedor de mensajería (WhatsApp/SMS) o número telefónico registrado de forma errónea.	Al médico (tiempo muerto), a la clínica (pérdida económica) y a otros pacientes que necesitaban el espacio.	Implementar una sintaxis de validación de números telefónicos antes de agendar y contar con reintentos de envío en caso de falla de entrega.

Elaborado por: Gustavo Ángel García Estrada

Tabla 2:

2. ***Que necesitamos***

¿Qué revisa?	Tu respuesta
Herramientas y datos: ¿Qué necesitamos?, ¿qué tenemos? y ¿qué falta comprobar?	Se necesitan servicios de mensajería masiva (API de WhatsApp/SMS), base de datos centralizada de citas y plantilla de confirmación. Tenemos la definición del problema y la propuesta de valor de U2-E01. Falta comprobar la tasa de ausentismo histórica para comparar resultados.
Personas: ¿Quién lo usaría?, ¿quién revisaría? y ¿qué tendría que aprender?	Lo usará el paciente para agendar y reagendar, y el personal de recepción para supervisar. Desde Calidad revisaremos la usabilidad y legibilidad de las notificaciones. Los pacientes aprenderán a confirmar citas por chat.
Tiempo y recurso: ¿qué equipo, acceso, tiempo o costo requiere? y ¿con qué contamos?	Se requiere presupuesto para el canal de notificaciones y tiempo de pruebas con usuarios piloto. Contamos con el diseño conceptual; falta confirmar el tiempo de respuesta del proveedor de mensajería.

Nota. Los datos históricos de inasistencia de la clínica y la lista de preguntas más frecuentes en ventanilla aún no están confirmados en el expediente del equipo.

3. ***Termina tu análisis***

La mejora puede funcionar si el flujo de interacción es fácil e intuitivo para cualquier tipo de usuario y si el envío de notificaciones automáticas es totalmente constante, porque de esta manera se disminuirá de forma directa el ausentismo y se desahogará la línea telefónica de recepción.

Lo que falta comprobar es la tasa real de preferencia de los pacientes por el asistente interactivo en comparación con las llamadas tradicionales y el porcentaje histórico de faltas a citas.

Lo averiguaría analizando las métricas de uso tras el lanzamiento piloto y aplicando encuestas rápidas de satisfacción al momento de confirmar la cita.

4. Fuentes utilizadas

Borrador grupal U2-E01 FantasticFour_CitaMed-IA: Secciones "Problema concreto", "Indicador de Evaluación", "Matriz de Supuestos" y "Justificación del Proceso Elegido".

Encuesta/Acuerdo interno de calidad: Parámetros de usabilidad y seguimiento del proceso de atención al cliente.

5. Uso de IA

Utilicé ChatGPT/Gemini unicamente como apoyo para la revisión de sintaxis, pulido del lenguaje técnico enfocado en calidad y estructuración general de las tablas.